# HELP_Organi_P16 — Groupe D — Lots 237 à 241 — 20 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 16 sur 30.

## Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

## Questions

### D-001 — Haute — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.1 › point 9 › tableau d'interprétation (rapport aldostérone/rénine)

**Contexte :** Le cours écrit : seuil « propre à la méthode et au laboratoire », valeur ESH non trouvée ; il s'appuie sur l'ESC/ESH 2018 (texte ESH 2023/ESC 2024 refusé, HTTP 403).

**Question :** Quels seuils de rapport aldostérone/rénine (en pmol/L et ng/L, selon la méthode : activité ou concentration de rénine) retiennent l'ESH 2023 et l'ESC 2024 pour dépister l'hyperaldostéronisme primaire ? Quelles conditions de prélèvement (kaliémie, arrêt des médicaments interférents) sont exigées ? Existe-t-il une position suisse (SSH, SSED) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-002 — Haute — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.1 › point 9.a gold standard et point 11 (HTA résistante, dépistage chimique de l'observance)

**Contexte :** Le cours cite l'ESC/ESH 2018 [S12] : dosage du médicament dans le sang ou l'urine comme méthode la plus exacte ; résistance vraie = PA ≥ 140/90 mmHg confirmée hors cabinet avec adhésion confirmée. ESH 2023 et ESC 2024 non lus.

**Question :** Que disent l'ESH 2023 et l'ESC 2024 (et la Société suisse d'hypertension, SSH) sur la définition de l'hypertension résistante, la pseudo-résistance et le dépistage chimique de l'observance (quand, comment, par quelle méthode) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-006 — Haute — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › fenêtre « hypoglycémies » ; P3 › DX.6 › fenêtre « hypoglycémie »

**Contexte :** Le cours écrit : seuil glycémique suisse de l'hypoglycémie non trouvé ; Smarter Medicine relie le contrôle strict chez l'âgé à l'hypoglycémie [S22].

**Question :** Quels seuils glycémiques (mmol/L) définissent l'hypoglycémie de niveau 1, 2 et 3 selon la SSED/SGED (version la plus récente) et la recommandation européenne (EASD/ADA consensus) ? Quelle cible d'HbA1c la SSED et la gériatrie suisse retiennent-elles chez la personne âgée fragile ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-008 — Haute — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.3 › points 1, 9 et 11 › pièges ESC/EAS, fenêtre « Interprétation de la CK (9.b) » et fenêtre « alternatives thérapeutiques » (grossesse)

**Contexte :** Le cours écrit : définitions ESC/EAS 2019 non lues ; cibles tirées d'une revue EHJ 2026 ; mise à jour ESC/EAS 2025 non lue (HTTP 403) ; référence suisse de la CK non trouvée ; alternative à l'atorvastatine pendant la grossesse non trouvée.

**Question :** Quelles cibles de LDL-cholestérol, quelle définition de l'intolérance aux statines et quels seuils de CK (× LSN) pour arrêter ou reprendre une statine donnent la mise à jour ESC/EAS 2025 et le consensus EAS sur les symptômes musculaires ? Quelle conduite hypolipémiante pendant la grossesse ? La AGLA (Groupe suisse lipides et athérosclérose) a-t-elle une position plus récente ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-011 — Haute — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.7 › point 11.B › tableau Halopéridol (Haldol® comprimés/gouttes, Haldol® decanoas), lignes « Posologie orale », « Durée », « Règle d'oubli » ; fenêtre QTc ; tableau kaliémie/magnésémie ; A › Bloc 1 › tableau des formes à action prolongée

**Contexte :** Le cours écrit : posologie orale d'Haldol® non trouvée (FI non récupérée) ; plafond oral-équivalent 20 mg/j en association au dépôt ; règle d'oubli de Haldol® decanoas absente de la FI ; formule de correction du QTc et magnésémie normale non trouvées.

**Question :** Quelles doses orales d'Haldol® (comprimés et gouttes) donne la FI suisse pour la schizophrénie, l'agitation et le sujet âgé, avec adaptations rénale et hépatique ? Que prévoit la FI d'Haldol® decanoas en cas d'injection retardée ou manquée ? Quelle formule de correction du QTc (Bazett, Fridericia) et quelle magnésémie cible recommandent la FI ou l'ESC 2022 (arythmies ventriculaires) ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-014 — Haute — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.9 › points 9 et 11.C › surveillance (charge virale VIH ; aminotransférases sous cabotégravir)

**Contexte :** Le cours tire les fréquences de mesure de l'EACS 12.0 (version 13.0 non lue) ; valeurs de référence des aminotransférases non trouvées.

**Question :** Que disent les EACS Guidelines 13.0 (2025) sur la fréquence de mesure de l'ARN du VIH-1 (instauration, stabilité, injectables cabotégravir + rilpivirine) et sur la surveillance hépatique sous cabotégravir ? Quelles différences avec la version 12.0 ? La Société suisse d'infectiologie / Swiss HIV Cohort Study a-t-elle une position propre ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-017 — Haute — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 › points 1, 11.B et 11.C › fenêtres « déprescription », « STOPP/START, Beers, PRISCUS », « Fiches pratiques de déprescription », « Polymedication-Check » ; surveillance biologique

**Contexte :** Le cours écrit : définition formelle de la déprescription non trouvée ; listes STOPP/START non lues ; schéma de sevrage des benzodiazépines, dose et spécialité non trouvés ; calendrier de surveillance (J3, J7, M1) non trouvé ; détail des aides à l'adhésion non trouvé (source principale : OPERAM, Smarter Medicine).

**Question :** Quelle définition de la déprescription et quels outils (STOPP/START version 3 de 2023, PRISCUS 2.0, EU(7)-PIM) recommandent les sociétés suisses (SSMIG, Société professionnelle suisse de gériatrie) ou européennes (EuGMS) ? Quel schéma de sevrage progressif des benzodiazépines et des hypnotiques chez la personne âgée est recommandé en Suisse ou en Europe (paliers, durée) ? Quel suivi clinique et biologique après arrêt ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-003 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 9.a gold standard ; repris dans P1 (DX.1, DX.2), P2 (DX.3–DX.5), P3 (DX.6–DX.7) et P4 (DX.8–DX.10) › point 9 › fenêtres « méthodes de mesure de l'adhésion », MPR/PDC/DPPR

**Contexte :** Le cours écrit, dans chaque DX : aucun gold standard (OMS 2003) ; sensibilité et spécificité des méthodes (dosage médicamenteux, questionnaires, comptage, monitoring électronique, MPR/PDC, DPPR, essai n-of-1, démonstration d'inhalation) non trouvées ; seuil de 80 % présenté comme convention d'étude.

**Question :** Quelles sensibilité et spécificité ont, pour détecter la non-adhésion, le dosage urinaire ou sanguin des médicaments, les questionnaires (MARS-5, Morisky/MMAS-8), le comptage des comprimés, le monitoring électronique (MEMS) et les indicateurs de délivrance (MPR, PDC, DPPR) ? Quel seuil (p. ex. PDC ≥ 80 %) les consensus européens (ESPACOMP, ABC/EMERGE) ou suisses retiennent-ils ? Citer les méta-analyses européennes les plus récentes.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-004 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.1 › point 9 › tableau d'interprétation (imagerie des artères rénales ; métanéphrines)

**Contexte :** Le cours cite l'ESC/ESH 2018, tableau 26 : sténose significative sans seuil chiffré ; métanéphrines : valeurs normales et seuil non trouvés.

**Question :** Quel degré de sténose de l'artère rénale (en %, critères Doppler : vitesse systolique maximale, index rénal-aortique) définit une sténose significative selon l'ESH 2023/ESC 2024 ? Quels seuils de métanéphrines plasmatiques libres ou urinaires orientent vers un phéochromocytome selon la recommandation européenne la plus récente (ESE/ENETS) ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-005 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 8 › fenêtre « La fréquence cardiaque sous bêtabloquant » et fenêtre « Constatations objectives selon le traitement » ; P1 › DX.1 › fenêtre « Fréquence cardiaque »

**Contexte :** Le cours écrit, d'après la SSH 2021 [S10] : une fréquence inadaptée sous bêtabloquant suggère la non-prise ; valeur cible chiffrée non trouvée.

**Question :** Quelle fréquence cardiaque de repos attendue ou cible sous bêtabloquant (hypertension, coronaropathie, insuffisance cardiaque) donnent la SSH, l'ESC 2023 (insuffisance cardiaque) et l'ESC 2024 (syndromes coronariens chroniques / hypertension) ? À partir de quelle fréquence une non-prise doit-elle être suspectée ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-007 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.2 › point 9 › tableaux d'interprétation (HbA1c, peptide C, anticorps, cétonurie, poids/IMC)

**Contexte :** Le cours cite la SGED/SSED 2023 [S100] : cibles d'HbA1c 7,0 % (53 mmol/mol), peptide C > 200 et < 600 pmol/L ; valeurs normales de l'HbA1c, seuils des anticorps anti-GAD/IA2/ZnT8 et seuil de cétonurie non trouvés ; IMC > 28 kg/m² pour le remboursement du GLP-1.

**Question :** Quelles valeurs de référence de l'HbA1c (mmol/mol et %) et quels seuils de cétonémie/cétonurie retient la SSED ? Quelle est la limitation actuelle de la Liste des spécialités (OFSP) pour les agonistes du GLP-1 et le sémaglutide (IMC, HbA1c, durée) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-009 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › P2 › DX.4 (FA, AOD) et DX.5 (asthme/BPCO) › point 2 ; P3 › DX.7 › fenêtre « insight » ; P4 › DX.8 › point 2 et fenêtre « Chiffres clés » ; A › Bloc 1 › point 2

**Contexte :** Le cours écrit : fréquences suisses de la non-adhésion dans la FA hors AVC, l'asthme, la schizophrénie et l'épilepsie non trouvées ; mortalité attribuable à la non-adhésion non chiffrée ; sexe non établi comme facteur (données OMS 2003 et mondiales).

**Question :** Existe-t-il des données suisses (Obsan, OFS, cohortes CoLaus, SSHF, études d'assureurs Helsana/CSS) sur la fréquence de la non-adhésion aux AOD dans la fibrillation auriculaire, aux corticoïdes inhalés dans l'asthme, aux antipsychotiques dans la schizophrénie et aux antiépileptiques ? À défaut, quelles données européennes récentes ? Quelle mortalité attribuable à la non-adhésion est publiée pour l'Europe ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-010 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 11.D (recherche) › piège « Zilébésiran / polypilule » ; P1 › DX.1 › fenêtre « Zilébésiran »

**Contexte :** Le cours écrit : zilébésiran = résultat de phase 1, numéro NCT non trouvé, autorisation suisse non vérifiée ; aucune polypilule cardiovasculaire dans la Liste des spécialités.

**Question :** Une polypilule cardiovasculaire (p. ex. Trinomia® : aspirine, ramipril, atorvastatine) est-elle autorisée par Swissmedic ou listée dans la LS ? Quels sont le statut et les numéros NCT des essais de phase 2/3 du zilébésiran (KARDIA-1, -2, -3) en 2026 ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-012 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 11.B › tableau des formes simplifiées (colonne « durée » / « Donnée non trouvée ») : Exforge HCT®, Ozempic®, Leqvio®, Biktarvy®

**Contexte :** Le cours donne les posologies FI mais écrit « donnée non trouvée » pour la durée de traitement (sauf tacrolimus) et pour l'effet de Leqvio® sur la morbi-mortalité.

**Question :** Pour Exforge HCT®, Ozempic®, Leqvio® et Biktarvy®, la FI suisse fixe-t-elle une durée de traitement ou une réévaluation, et quelles données grossesse/allaitement donne-t-elle ? Le résultat de l'essai ORION-4 ou VICTORION-2-PREVENT sur la morbi-mortalité de l'inclisiran est-il publié et intégré à la FI ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-016 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.8 › point 6 › tableau des mimes « cause aiguë qui mime la rupture » ; et LOT_239 Appel A (exemples d'aptitude : crise provoquée)

**Contexte :** Le cours écrit : « une crise provoquée n'est pas une crise non provoquée » [S402] ; valeurs seuils (glycémie, natrémie, calcémie…) non trouvées. L'audit du LOT 239 Appel A demande une définition sourcée de la crise provoquée.

**Question :** Quelle définition et quels seuils biologiques (glycémie, natrémie, calcémie, magnésémie, urémie, délai après AVC ou traumatisme) la Commission ILAE retient-elle pour la crise symptomatique aiguë (provoquée) ? Quelle est la version la plus récente (Beghi 2010 ou ultérieure) ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-018 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 › fenêtre « Polymedication-Check »

**Contexte :** Le cours écrit : revue de médication en pharmacie dès 4 médicaments depuis plus de 3 mois, remboursée ; durée de l'entretien non trouvée.

**Question :** Quelles sont les conditions actuelles (2026) du Polymedication-Check (pharmaSuisse, convention tarifaire LOA/RBP) : critères d'accès, durée, rémunération, fréquence admise ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-019 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 › fenêtres « Mini Mental Status Examination (MMSE) » et MacCAT-T ; LOT_238 P4 › DX.9 › fenêtre « Décision pour un patient incapable de discernement » et tableau MMSE ; LOT_241 P4 › DX.9 › fenêtre « Capacité de discernement »

**Contexte :** Le cours cite les directives ASSM sur la capacité de discernement (2019) : le MMSE ne mesure pas la capacité ; seuils du MMSE et du MacCAT-T non trouvés ; le LOT 238 écrit que ces directives n'ont pas été lues ; le LOT 241 n'en a pas la base légale précise.

**Question :** Que disent les directives médico-éthiques de l'ASSM « Évaluation de la capacité de discernement dans la pratique médicale » (année, URL, version en vigueur) sur la méthode, les instruments (MMSE, MacCAT-T, U-Doc) et leurs seuils ? Quelle base légale (CC art. 16, art. 377 ss) s'applique ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-020 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.7 › fenêtres « signes extrapyramidaux », « Akathisie », « Hypotension orthostatique » ; tableau « Poids, glycémie » ; surveillance J3/J7/M1

**Contexte :** Le cours écrit : technique d'examen des signes extrapyramidaux, définition formelle de l'akathisie, seuil d'hypotension orthostatique, valeurs et calendrier de surveillance métabolique sous antipsychotiques non trouvés.

**Question :** Quel calendrier de surveillance métabolique et cardiaque (poids, tour de taille, glycémie/HbA1c, lipides, prolactine, ECG) sous antipsychotique recommandent la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) ou l'EPA ? Quel seuil définit l'hypotension orthostatique (consensus européen ESC/EFAS) ? Quelles échelles (Barnes, Simpson-Angus, AIMS) servent à dépister akathisie et signes extrapyramidaux ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-021 — Moyenne — LOT 237 · SSP O7.15

**Emplacement :** LOT_237_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › fenêtres « anurie », « idées délirantes et hallucinations », « états comateux » ; P3 › DX.6 › fenêtre « chute »

**Contexte :** Le cours écrit : seuil chiffré de l'anurie, définition clinique du coma, définitions formelles des idées délirantes, des hallucinations et de la chute non trouvés.

**Question :** Quelles définitions sourcées (CIM-11 OMS, KDIGO, ProFaNE/OMS pour la chute, échelle de Glasgow) donner pour : anurie (seuil en mL/24 h), oligurie, coma, idée délirante, hallucination et chute ?

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## D-022 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

**Emplacement :** LOT_238_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 9 › tableau « interprétation des examens » (ECG, hs-cTn, BNP/NT-proBNP, ETT, tests plaquettaires, spirométrie, polysomnographie) ; P2 › DX.4 › biomarqueurs ; LOT_240 P3 › DX.7 › tableau BNP/NT-proBNP et ECG

**Contexte :** Le cours écrit : classes ESC 2022 obtenues par transcription secondaire [S9] (tableaux originaux non lus, HTTP 403) ; NT-proBNP ≥ 300 pg/mL et BNP ≥ 92 pg/mL attribués aux CCS canadiens, non à l'ESC ; hs-cTnT > 14 ng/L ; classe de l'ECG préopératoire de routine non précisée ; LOT 240 : aucun seuil de BNP trouvé.

**Question :** Dans la guideline ESC 2022 sur l'évaluation cardiovasculaire avant chirurgie non cardiaque, quels sont le texte original, la classe et le niveau de preuve pour : hs-cTn avant et après

chirurgie, BNP/NT-proBNP (avec ou sans seuil chiffré), ECG préopératoire (y compris de routine chez le patient à bas risque), échocardiographie, imagerie de stress ? Une mise à jour ESC postérieure à 2022 existe-t-elle ? La SSAPM (Société suisse d'anesthésiologie et de médecine périopératoire) a-t-elle une position ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P16 — 20 questions : D-001, D-002, D-006, D-008, D-011, D-014, D-017, D-003, D-004, D-005, D-007, D-009, D-010, D-012, D-016, D-018, D-019, D-020, D-021, D-022